# Douleurs Thoraciques

d’origine cardiaque

***Dr Merar***
***Assistante en cardiologie***

# *Introduction*

C’est un motif de consultation très extrêmement fréquent.

Le but primaire de la prise en charge est surtout d’eliminer une urgence

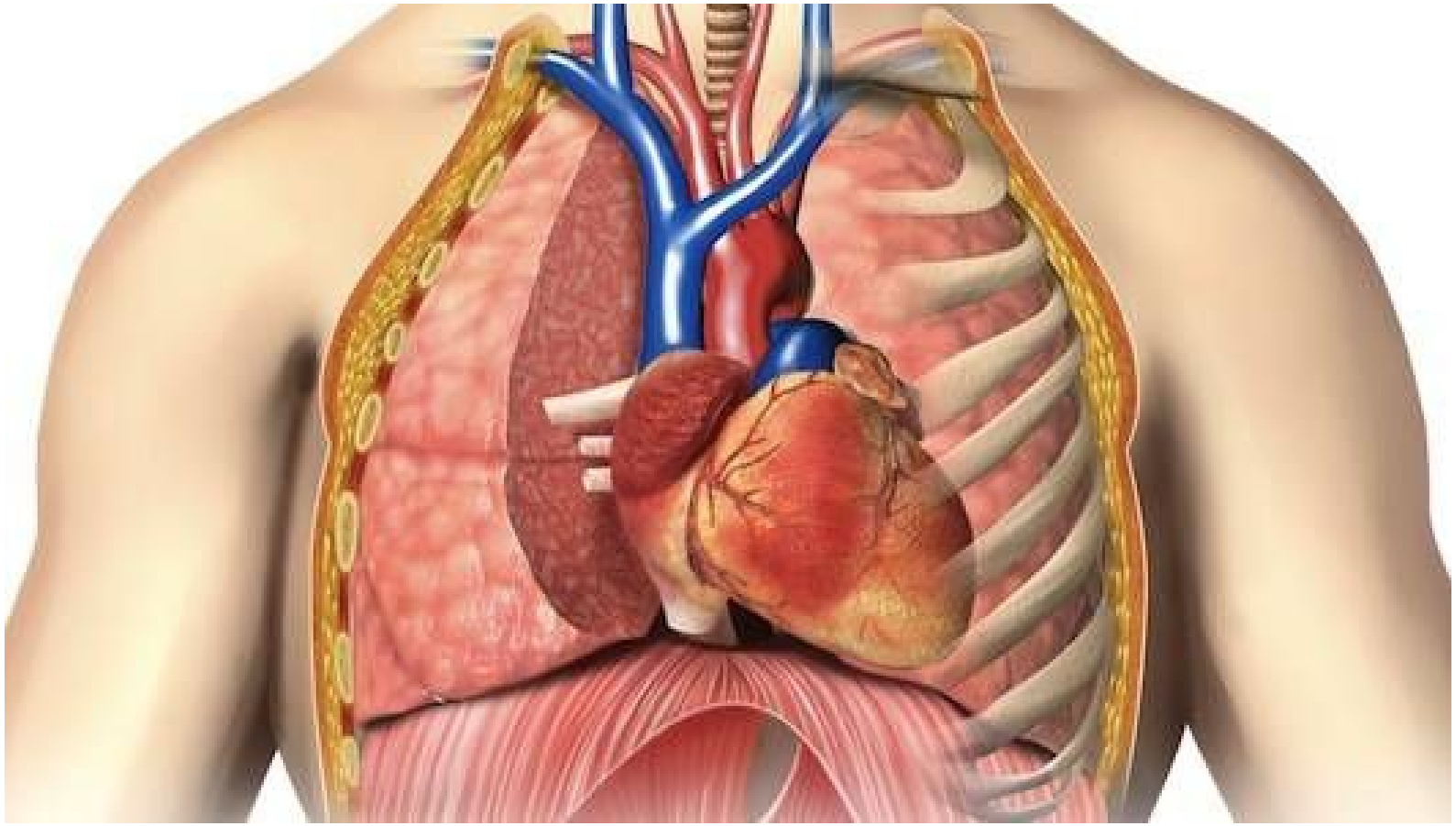
# L’interrogatoire doit :

Rechercher les FDRCV , les antécédents medicochirugicaux et surtout cardiologiques , la prise d’un traitement au long cours.

Il doit être précis et non directif et doit faire préciser au patient **les caractéristiques de la douleur qui permettent souvent d’approcher le diagnostic.**

- ✓ **Circonstances d’apparition**
- ✓ **Le siège et les irradiations**
- ✓ **Le type et l’intensité**
- ✓ **la durée**
- ✓ **les signes accompagnateurs**
- ✓ **L’evolution dans le temps**
- ✓ **Les facteurs sédatifs**

# Qu’est ce qui fait mal dans le thorax ?



# Etiologies : PIED

**P** : Péricardite

**I** : IDM

**E** : Embolie pulmonaire

**D** : Dissection de l’aorte

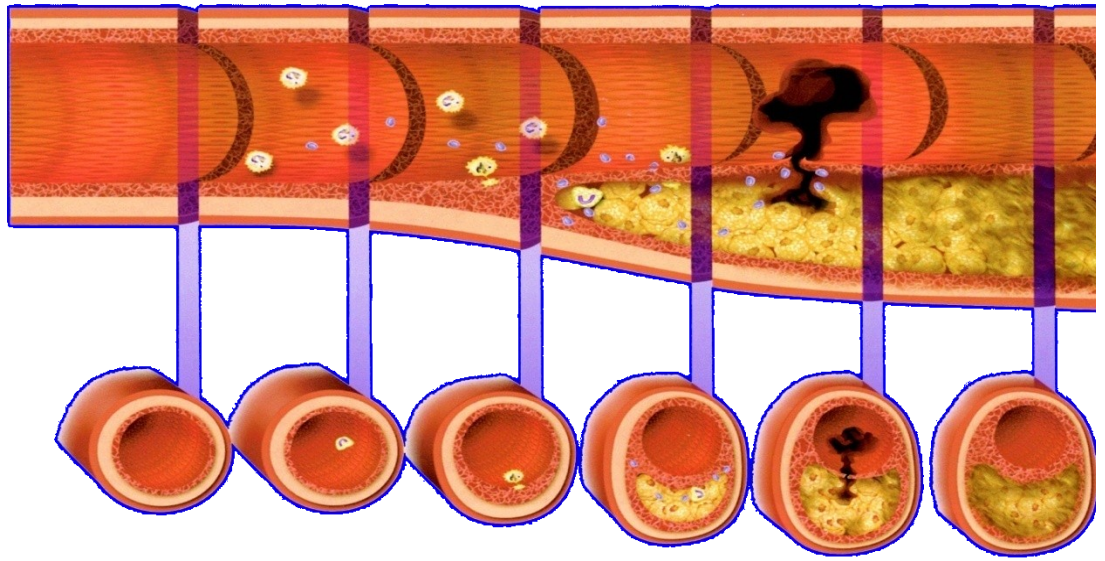
# PÉRICARDITE

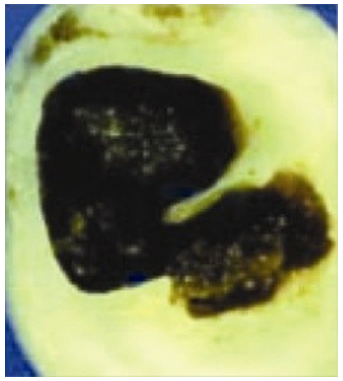
- ✓ Douleur précordiale , rétrosternale , prolongée
- ✓ Augmentation par l’inspiration profonde
- ✓ Calmée par l’antéflexion
- ✓ +/- fièvre
- ✓ Frottement péricardique

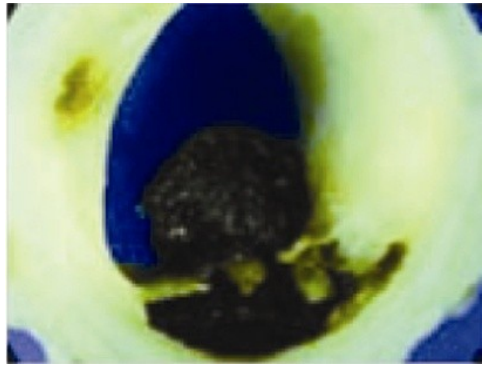
Evolution caractéristique de l’ECG +/- épanchement péricardique à l’ ETT

# Douleur du syndrome coronaire : Douleur angineuse

Englobe le syndrome coronaire chronique et le syndrome coronaire aigu







# Douleur du syndrome coronaire : Douleur angineuse

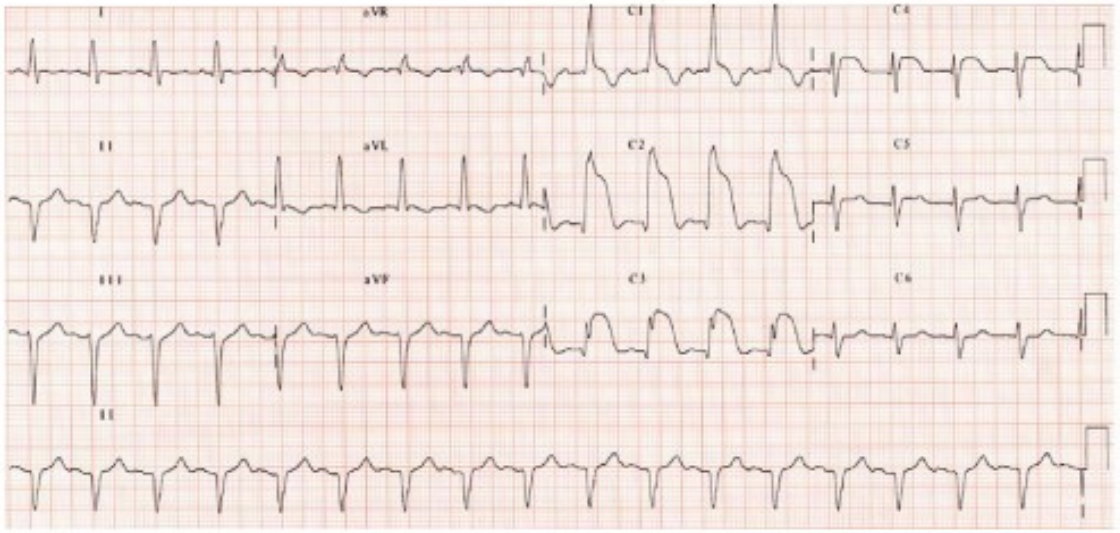
**Angor chronique stable**

- ✓ **A l'effort**
- ✓ **Diminue ou s'arrête au repos**
- ✓ **Rétrosternale en barre**
- ✓ **Irradie aux deux bras et à la machoir inférieure**
- ✓ **Calmée rapidement par la trinitrine**

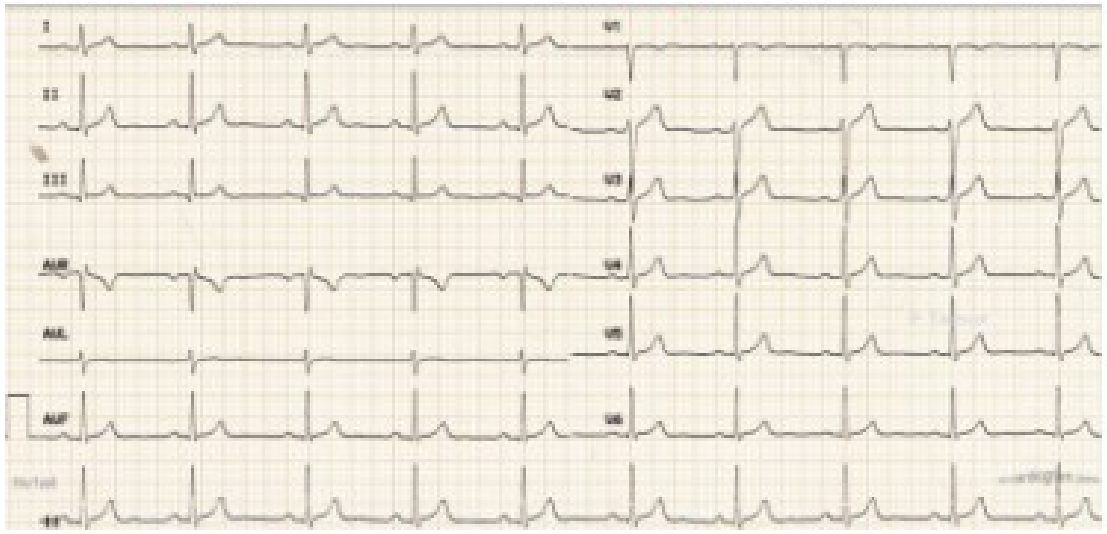
**Sd coronaire aigu**

- ✓ **Douleur type angineux mais :**
- ✓ **Au repos**
- ✓ **Prolongée** >20 mn
- ✓ **Trinitroresistante**

# Faire un ECG dans les 10 mn suivant le premier contact médical ++

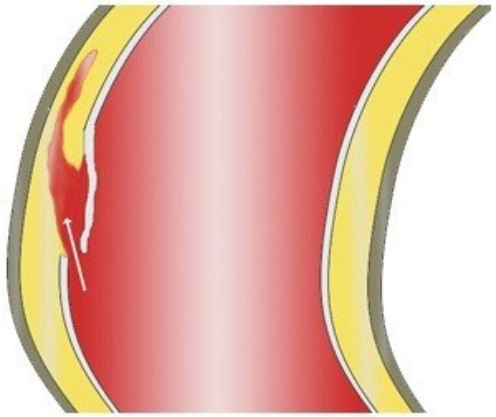


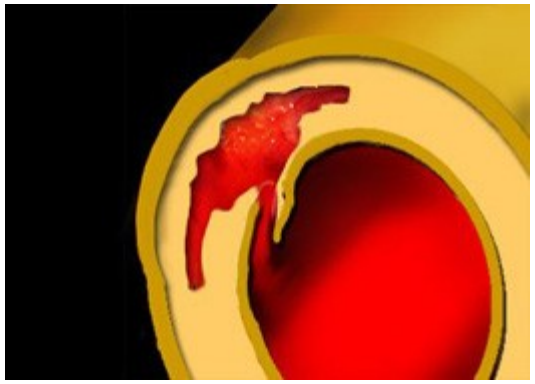
SCA avec sus décalage du segment ST

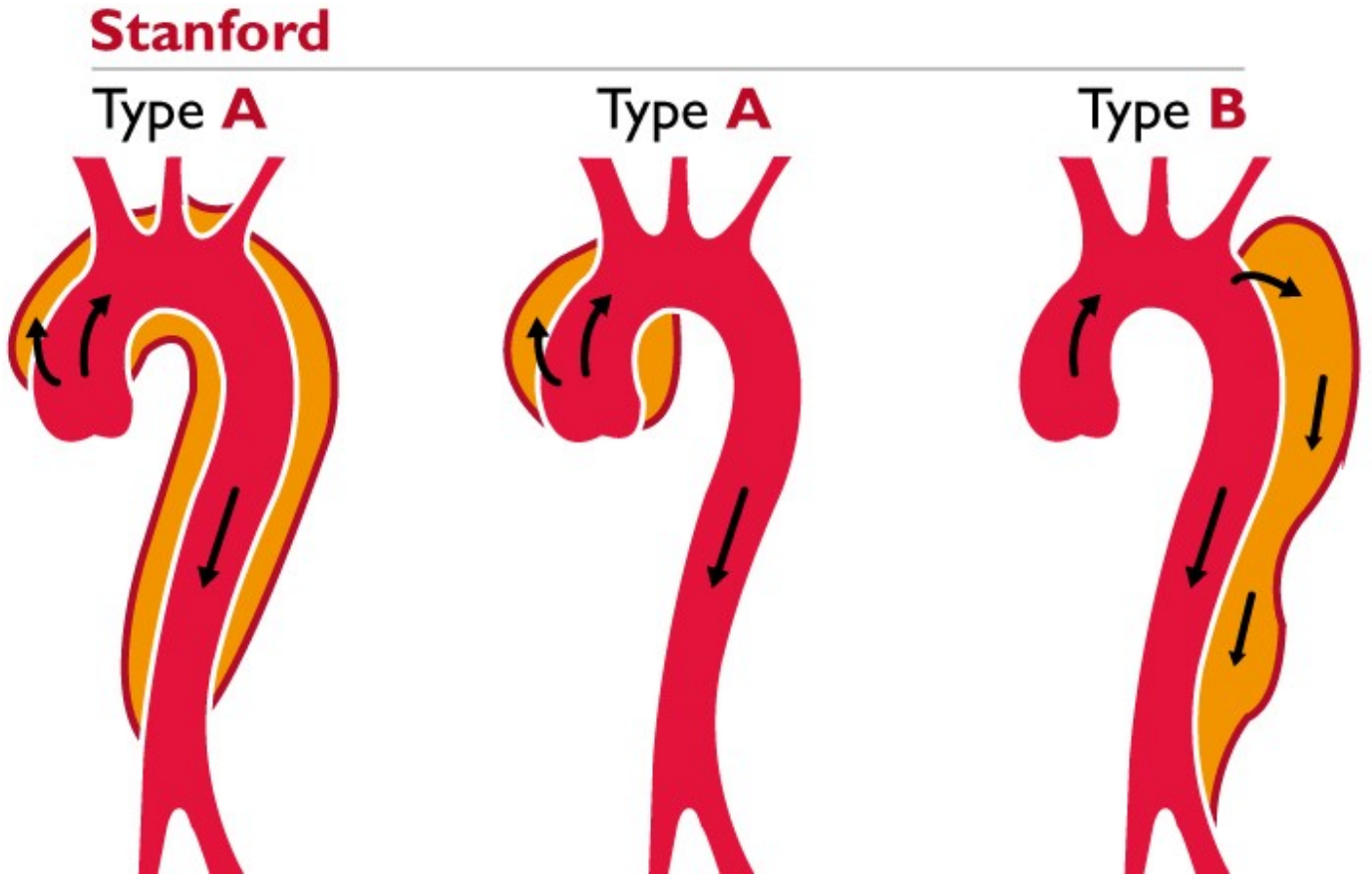


ECG Normal

# Dissection de l’aorte







# Dissection de l’aorte :

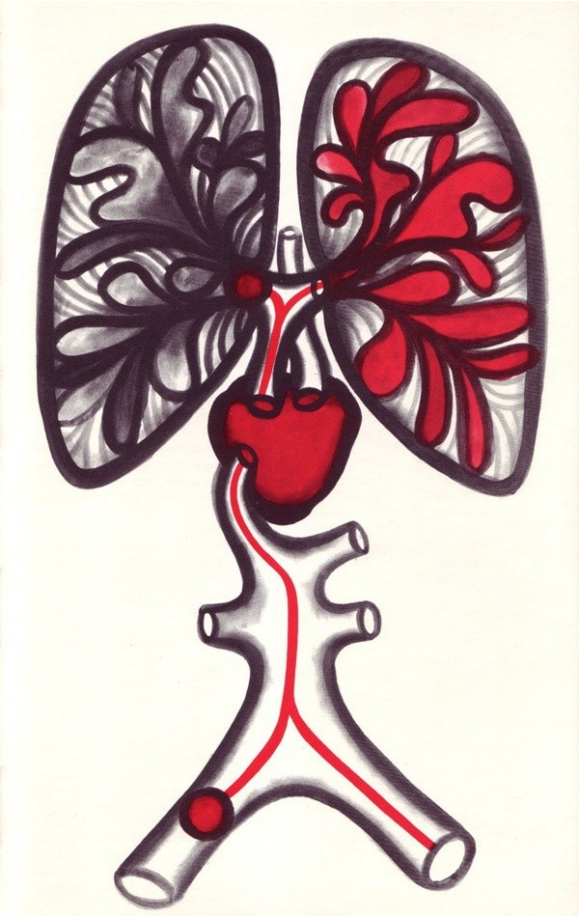
- ✓ Classiquement : Douleur **migratrice** très intense , angoissante
- ✓ Difficilement calmée par les antalgiques majeurs
- ✓ Débutant dans la thorax puis dos , lombes et membres inférieurs

**Signes accompagnateurs :** Asymetrie des pouls , asymétrie tensionnelle aux deux bras > 20 mmhg

Souffle diastolique d’insuffisance aortique ( Type A )

# Embolie Pulmonaire :

- ✓ Douleur violente à type de point de côté , coup de poignard
- ✓ A la base du thorax
- ✓ Signes accompagnateurs : Dyspnée, angoisse , hémoptysie



# Diagnostic Differentiel

Les douleurs d'origine non cardiaques sont des douleurs anorganiques, le cœur est indemne. Elles peuvent être de plusieurs origines :

- **D'origine digestive :** Le reflux œsogastrique, L'ulcère Castro duodénal
- **d'origine neuro musculaire :** Elles peuvent s'observer lors des hernies discales dorsales ou cervicales comprimant les racines nerveuses.

- **d'origine squelettique :** Elles peuvent apparaître à l'occasion d'arthrite de l'épaule, de la colonne vertébrale, parfois de simples douleurs musculaires intercostales peuvent irradier au thorax
- **D'origine névrotique** : entrant dans le cadre de la névrose cardiaque. Il s'agit d'un sujet au profil psychologique particulier, anxieux et émotif cherchant à se réfugier dans la maladie.

## Principales causes cardiaques :

| | Péricardite | Coronarienne (Angor, Infarctus) | Embolie pulmonaire | Dissection aortique |
|---|---|---|---|---|
| Siège | Précordiale | Rétrosternale | basithoracique | retrosternale |
| Intensité | Intense ou violente | Variable, souvent angoisante | Douleur sourde, parfois intense | Violente |
| Type | Coup de poignard, brûlure | Constrictive, oppression, étau, pesanteur | Coup de poignard, point | Déchirure |
| Irradiation | Aucune | Mâchoire, épaules, bras | Aucune | transfixiante et descendante |
| Survenue | Spontanée, Augmentée par l'inspiration, la position allongée | A l'effort | Spontanée augmentée par la respiration, la toux | Spontanée |
| Durée | Plusieurs heures, jours | Quelques minutes à prolongée, ( > 20 mn) | Variable | Plusieurs heures |
| Diminution | Penché en avant, anti-inflammatoires | Arrêt de l'effort, trinitrine | Rien | Rien |

***Merci de votre attention***